

DOCUMENTO PARA JUNTA MÉDICA

Síntesis ejecutiva — apto para discusión interdisciplinaria

12 / 01 / 2027

PACIENTE

Jorge Eliécer Salazar Pinzón
DOCUMENTO

CC 79555111

EDAD

46 años, 2 meses

ESCOLARIDAD / OCUPACIÓN

Tecnólogo · Técnico electricista (incapacitado por accidente)

PROTOCOLO

peritaje_medicolegal_adulto
CIE-10

MOTIVO DE INTERCONSULTA

Pregunta clínica que motiva la presentación

PERITAJE NEUROPSICOLÓGICO ordenado por Juzgado 14 Laboral del Circuito. Paciente sufrió TEC moderado en accidente laboral el 2025-08-15 (caída de 4 metros). Demanda en curso contra la empresa constructora. La evaluación es para DETERMINAR SECUELAS COGNITIVAS y capacidad laboral residual.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Perfil neuropsicológico global: $Z = +0.7\sigma$ sobre 4 dominios evaluados.

Hallazgos clave

- Memoria Visuoespacial moderadamente descendido ($Z = -1.3\sigma$)
- Memoria de Trabajo preservado ($Z = +3.0\sigma$)

Implicación

Se sugiere intervención dirigida al dominio descendido, con monitoreo de respuesta a tratamiento.

RESULTADOS CLAVE

Síntesis cuantitativa

Inventario de Be

18

Leve

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: memoria visuoespacial (moderadamente disminuido, $Z = -1.3$). Por su parte, destacan como áreas preservadas o por encima del promedio: memoria de trabajo (muy alto, $Z = +3.0$); comprensión verbal (alto, $Z = +1.0$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Figura de Rey ($Z = -1.34$, límite); CONSTRUCCIÓN CUBOS ($Z = -1.00$, promedio); ROMPECABEZAS ($Z = -1.00$, promedio). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Debilidades

- Figura de Rey — límite ($Z = -1.34$)
- CONSTRUCCIÓN CUBOS — promedio ($Z = -1.00$)
- ROMPECABEZAS — promedio ($Z = -1.00$)

Fortalezas

- HISTORIETAS — superior ($Z = +3.00$)
- LETRAS Y NÚMEROS — superior ($Z = +3.00$)
- COMPRENSIÓN — superior ($Z = +2.00$)

HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA Y PREGUNTAS A LA JUNTA

Síntesis interpretativa

Diagnóstico tentativo

CIE-10: F07

Impresión diagnóstica: F07.2 - Síndrome post-concusional + demanda laboral activa

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

Familiar

- Psicoeducación a esposa e hijos sobre el perfil de secuela, manejo conductual en casa, expectativas realistas de recuperación.

General

- [LABORAL] Paciente presenta SECUELAS COGNITIVAS SIGNIFICATIVAS compatibles con síndrome post-concusional crónico. Capacidad laboral residual estimada: 40-50% de su nivel pre-lesional.
- [LABORAL] Implicaciones para la demanda: Las alteraciones en funciones ejecutivas y memoria documentadas SON CONSISTENTES con el TEC moderado del 2025-08-15 (mecanismo plausible, temporalidad coherente, perfil neuropsicológico típico).
- [LEGAL] Documentación completa disponible para el juzgado. Se anexa: batería administrada, resultados normativos, análisis de validez, correlación anátomo-clínica, y respuesta a cada pregunta del auto interlocutorio.
- [LABORAL] Limitaciones específicas: no apto para trabajo en alturas, no apto para tareas que requieran alta velocidad de procesamiento o toma rápida de decisiones en condiciones de riesgo. Requiere supervisión y pausas estructuradas.

Terapéutica

- Indispensable: programa de rehabilitación neuropsicológica de 6 meses (mínimo 24 sesiones) con foco en funciones ejecutivas y estrategias compensatorias de memoria.
- Tratamiento farmacológico de la sintomatología depresiva-ansiosa por psiquiatría (ISRS). Psicoterapia breve de apoyo.

Recomendaciones del cuadro clínico

Banco de recomendaciones clínicas sugeridas para el cuadro identificado. El clínico debe seleccionar las aplicables antes de emitir el informe definitivo.

Discapacidad intelectual adulto (F70–F79) · Adulto (18–49 años)

- Valoración para proceso de interdicción / apoyos legales según Ley 1996 de 2019.
- Programa de inclusión laboral / ocupacional adaptado a su nivel.
- Entrenamiento en AVD y autonomía: transporte, manejo de dinero, autocuidado.
- Acompañamiento psicosocial para red de apoyo familiar.
- Manejo de comorbilidades psiquiátricas (ansiedad, depresión) — frecuentes.
- Control médico integral — mayor riesgo de enfermedades no detectadas por dificultad para comunicar síntomas.
- Actividades de estimulación cognitiva adaptadas al nivel funcional.
- Psicoeducación sexual y prevención de abuso.